

ABCES DU POUMON

YACINE DIA KANE

MCA

PNEUMOLOGIE FANN/DAKAR

GENERALITES:DEFINITION

- Suppuration collectée dans une **cavité néoformée**

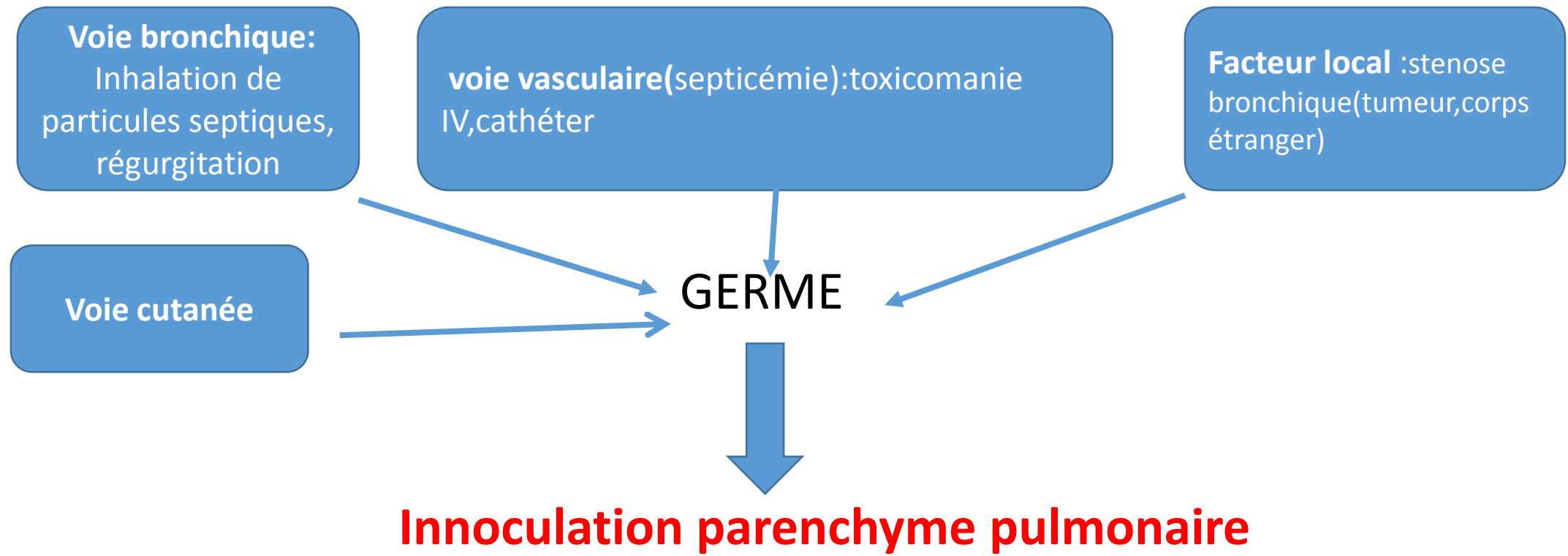
creusée en plein **parenchyme pulmonaire**

par une **inflammation aiguë** non tuberculeuse

GENERALITES:INTERET

- Formes classiques rares → banalisation antibiothérapie
- Germes responsables souvent résistants
- Traitement: antibiothérapie précoce prolongée
- Pronostic vital menacé :complications à distance

GENERALITES:PATHOGENIE



GENERALITES:PATHOGENIE

Innoculation parenchyme pulmonaire



Zone inflammation: alvéolite fibrinoleucocytaire= hépatisation



Transformation purulente rapide



Evacuation bronchique



CAVITE

GENERALITES:ANATOMIE PATHOLOGIQUE

- MACROSCOPIE:**

Siège prédilection: lobes inférieurs (droit +++)

Nombre:Abscs unique ou multiple

Aspect: zone hépatisée + excavation à contenu purulent

GENERALITES:ANATOMIE PATHOLOGIQUE

- MICROSCOPIE:

Abcès aigus: alvéoles infiltrées de polynucléaires et alvéolite fibrino-leucocytaire + bronche de drainage remaniée

Abcès chroniques: tissu de sclérose pariétale

DIAGNOSTIC POSITIF

- **CLINIQUE**
- **Phase foyer fermé** :début progressif
 - Signes fonctionnels
 - Douleur thoracique fixe ,point côté
 - Toux sèche ou peu productive, douloureuse
 - Dyspnée modérée

DIAGNOSTIC POSITIF

- **CLINIQUE**
- **Phase foyer fermé**
 - Signes physiques
 - Submatité
 - Foyer râles crépitants
 - Rarement souffle tubaire

DIAGNOSTIC POSITIF

- **CLINIQUE**
- **Phase foyer fermé**
 - Signes généraux
 - Fièvre 38°/39°C
 - Pouls accéléré
 - Asthénie
 - Anorexie

DIAGNOSTIC POSITIF

- **CLINIQUE**
- **Vomique:** rejet, dans un effort violent de toux, d'une quantité importante de pus
- signes annonciateurs ou prodromes
 - Accès fétidité haleine.
 - Petites hémoptysies
 - Douleur thoracique déchirante allure syncopale
- Massive ou fractionnée

DIAGNOSTIC POSITIF

- **CLINIQUE**

- **Phase foyer ouvert**

- Signes fonctionnels

- Toux productive, expectoration franchement purulente(dresser courbe)

- Atténuation douleur

- Signes généraux:

- Fièvre oscillante, croisement courbes température et expectoration

- Amaigrissement

DIAGNOSTIC POSITIF

- **CLINIQUE**
- **Phase de foyer ouvert**
 - signes physiques
 - Râles bronchiques
 - Souffle cavitaire.
 - Zone condensation pulmonaire

DIAGNOSTIC POSITIF

- **PARACLINIQUE**
- Imagerie thoracique
 - Radiographie de thorax :
 - **foyer fermé: opacité dense, homogène, mal systématisée et à limites floues**

DIAGNOSTIC POSITIF

- **PARACLINIQUE**
- Imagerie thoracique
 - Radiographie de thorax :
 - **foyer ouvert:**
 - **Image hydro-aérique**, image arrondie, formée d'une opacité basale liquidienne surmontée d'une clarté aérique, séparées l'une de l'autre par une limite horizontale
 - ± Bronche de drainage
 - Variabilité niveau sur plusieurs examens

DIAGNOSTIC POSITIF

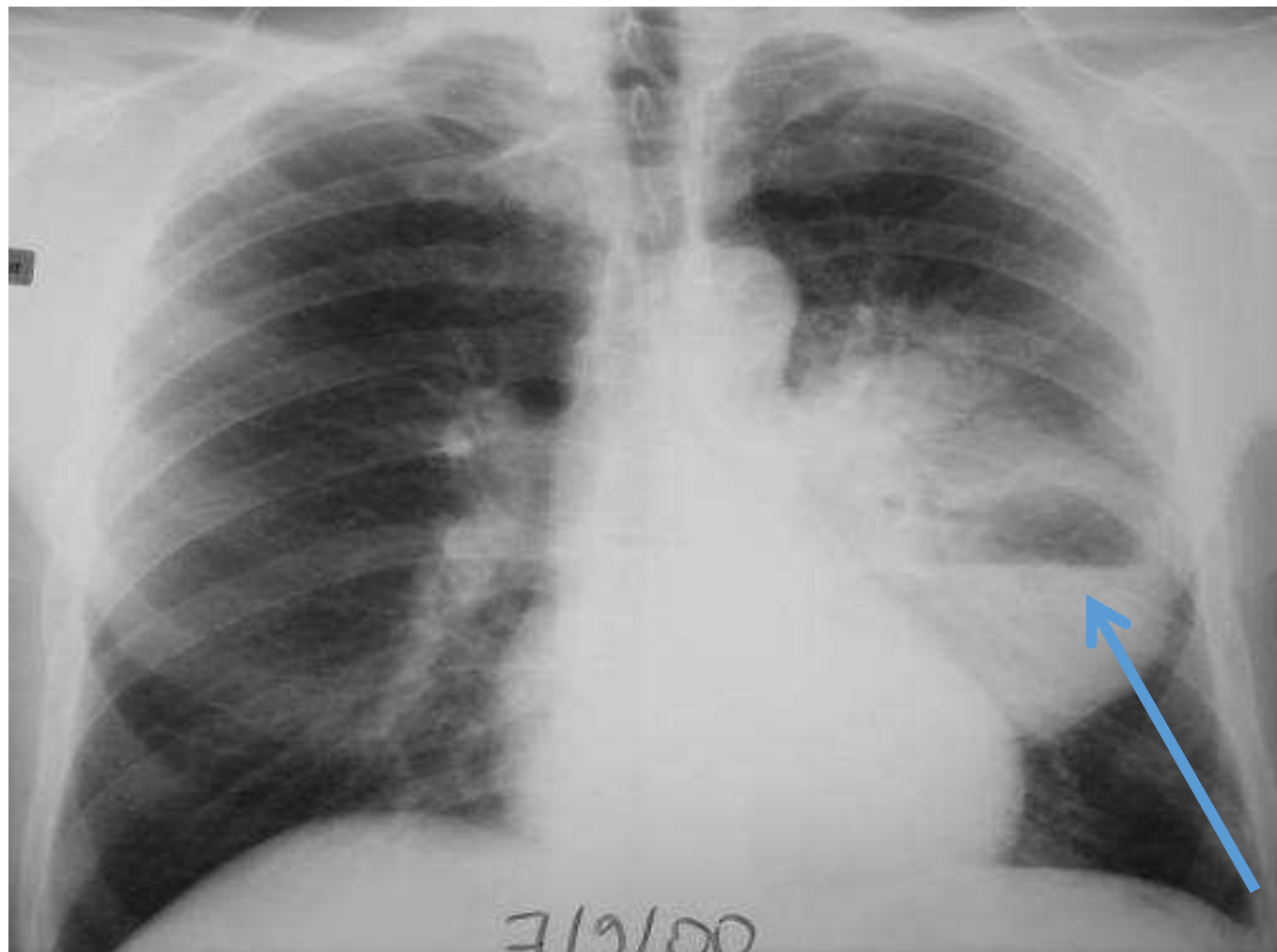
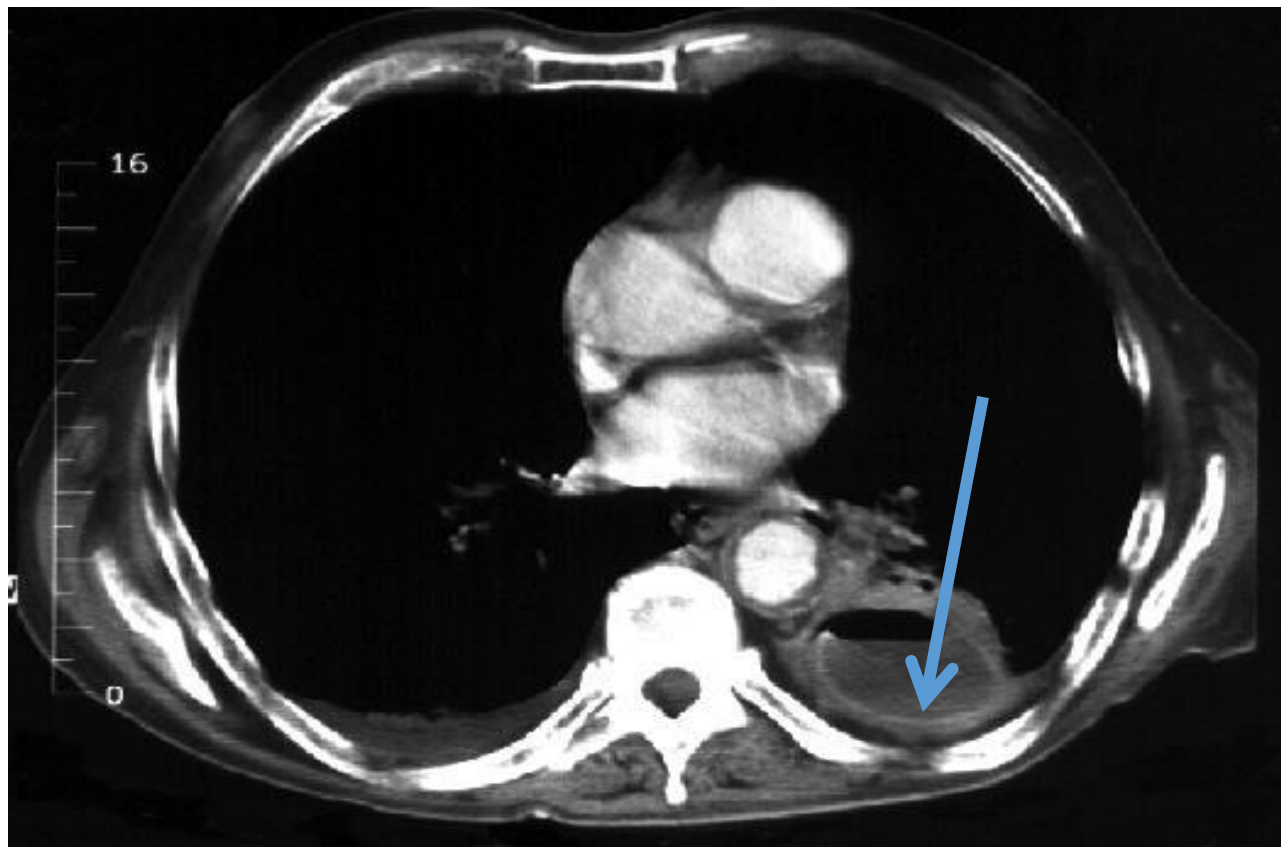


IMAGE HYDRO-AERIQUE

DIAGNOSTIC POSITIF

- **PARACLINIQUE**
- **Imagerie thoracique**
 - **Scanner thoracique** : Précise
 - nombre
 - siège
 - nature excavée lésions
 - présence de niveaux liquidiens



**IMAGE HYDROAERIQUE AU
SCANNER**

DIAGNOSTIC POSITIF

- **PARACLINIQUE**
- **ECBE(Examen Cyto- Bactériologique de l'Expectoration):**
 - Etudie flore bactérienne
 - Détermine germe dominant
 - Pratique un antibiogramme.
 - Recherche BK (**résultats** doivent être **négatifs**).

DIAGNOSTIC POSITIF

- **PARACLINIQUE**
- **Examens biologiques:**
 - NFS hyperleucocytose à PNN,
 - VS accélérée et
 - Hyperfibrinémie
 - Recherche tare métabolique/Diabète
- **Hémocultures** répétées si pic fébrile.

DIAGNOSTIC POSITIF

- **PARACLINIQUE**
- **Fibroscopie bronchique :**
 - localise suppuration
 - permet prélèvements
 - vérifie perméabilité bronches explorées(corps étranger, **masse tumorale**)

DIAGNOSTIC POSITIF

- **EVOLUTION:** surveillance clinique et paraclinique
- **Favorable** → 8 jours
 - Amélioration signes fonctionnels et physiques
 - Apyrexie stable
- persistance signes radiologiques normalisation environ 2 à 3 semaines:
restitution ad integrum, image stellaire

DIAGNOSTIC POSITIF

- **EVOLUTION:**
- **Défavorable**
 - Cavité résiduelle abcès chronique
 - Dilatation De Bronches(DDB)
 - Pleurésie séro-fibrineuse bactérienne
 - Pleurésie purulente
 - Hémoptysies (DDB ou greffe aspergillaire)

DIAGNOSTIC POSITIF

- **EVOLUTION:**
- **Défavorable**
 - complications générales :abcès à distance
 - rénal
 - Cérébral +++ →pronostic redoutable

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

- **Suppurations** sur **cavités** préexistantes
- **Tuberculose pulmonaire** commune excavée (contage, signes imprégnation, BK positifs)
- **Cancer bronchopulmonaire** excavé(tabagique+++,cavité paroi épaisse ,irrégulière,confirmation anatomo-pathologique)
- **Kyste hydatique**(vomique hydatique)
- **Pyopneumothorax** (radio profil ou TDM confirme)

DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE

- **Anaérobies:** peptostreptocoques, *Bactéroïdes fragilis* etc....
 - sujets éthyliques +++
 - formes gangreneuses putrides
 - abcès à distance

DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE

- ***Klebsiella pneumoniae* ou bacille de *Friedlander***
 - Expectorations hémoptoïques
 - Evolution sévère
 - séquelles importantes :cavités multiples.

DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE

- ***Staphylococcus aureus:***
 - Nourrisson ou adulte immunodéprimé
 - Signes digestifs ballonnement abdominal (nourrisson)
 - Imagerie thoracique :abcés multiples évolution vers images bulleuses
→rupture dans cavité pleurale →pyo-pneumothorax

DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE

- **Autres germes:**
 - *Streptococcus pneumoniae*
 - *Hémophilus influenzae*
 - Autres bactéries Gram Négatifs(BGN)/ *Pseudomonas aeruginosa*
 - Abscès parasitaire: amibien(rechercher antécédents séjour zone d'endémie ou foyer amibien suppuré)

TRAITEMENT

- **BUTS**

- Stériliser foyer infectieux
- Eviter et traiter les complications

TRAITEMENT

- **MOYENS**
- Mesures hygiéno-diététiques
- Médicamenteux
 - Antibiotiques en iv puis peros
 - Bétalactamines
 - Aminopenicillines (ex : amoxicilline $\pm$ acide clavulanique)
 - Céphalosporines (C3G)
 - Aminosides
 - Imidazolés

TRAITEMENT

- **MOYENS**
- Mesures hygiéno-diététiques(MHD)
- Médicamenteux
 - Antalgiques/Antipyrétiques: au besoin→ éviter masquer fièvre

TRAITEMENT

- **MOYENS**
- **Instrumentaux**
 - Kinésithérapie respiratoire : **drainage** cavité suppurée (**drainage de posture**)
 - Drainage cavité pleurale

TRAITEMENT

- **MOYENS**
- **Chirurgicaux**
 - Résection atypique
 - Ségmentectomie
 - Lobectomie
 - Pneumonectomie

TRAITEMENT

- **INDICATIONS**
 - **Abcès non compliqué**
 - MHD
 - Antibiothérapie probabiliste synergique, adapté : Exemple
 - bétalactamine+aminoside
 - Bétalactamine +aminoside± imidazolé
 - Revoir antibiothérapie après antibiogramme
 - Durée → 6 à 8 semaines
- Kinésithérapie respiratoire

TRAITEMENT

- **INDICATIONS**

- **Pleurésie purulente**

- Antibiothérapie
- Drainage pleurale+lavage
- Kinésithérapie respiratoire

TRAITEMENT

- **INDICATIONS**

- **Cavité résiduelle symptomatique:**

- hémoptysies répétées,
- suppurations récidivantes

➔ Chirurgie selon topographie

TRAITEMENT

- **PREVENTION**

- Traitement foyer infectieux ORL,dentaire, cutané...
- Prise en charge pneumopathie bactérienne
- Sevrage alcoolique et tabagique

CONCLUSION

- Pathologie potentiellement grave
- Profil clinique actuel modifié par antibiothérapie
- Prise en charge doit être précoce